

Cambiamento dei concetti, modelli interpretativi e classificazioni della disabilità

Percorsi nelle Disabilità · Sessione 05 · 24 marzo 2026

Questa lezione è densa ma fondamentale: capire come sono cambiati i concetti di disabilità nel tempo — e le parole che usiamo per descriverla — è la base per lavorare bene nel settore. Si passa da un'idea di "persona da riparare" a una di "società da adattare". Una rivoluzione copernicana.

Il linguaggio conta: come chiamiamo le persone con disabilità

Prima ancora di parlare di modelli teorici, si apre con un tema pratico: le parole. Le **Raccomandazioni SUPSI "Esprimersi... Diversamente!"** chiariscono che **il linguaggio non è neutro — riflette e rinforza la visione che abbiamo della persona.**

L'evoluzione terminologica non è capriccio politically correct: segue l'evoluzione dei modelli interpretativi.

Termine (da evitare)	Problema	Termine preferibile
Invalido	Retaggio assicurativo, nega la persona	Persona con disabilità
Handicappato / Disabile (come sostantivo)	Riduce la persona al deficit	Persona con disabilità
Diversamente abile		

Termine (da evitare)	Problema	Termine preferibile
	Presuppone sempre capacità alternative — non è necessariamente vero	Persona con disabilità
Portatore di handicap	La persona <i>vive</i> situazioni di handicap, non le <i>porta</i>	Persona in situazione di handicap
Il cieco / Il sordo	Riduce la persona a un singolo tratto	Persona con disabilità visiva / uditiva

La regola d'oro: **la persona viene prima del deficit**. Non "il disabile" ma "la persona con disabilità". Non "lo studente handicappato" ma "lo studente con disabilità".

La disabilità nel mondo: una realtà che riguarda tutti

La disabilità non è una questione di nicchia. Alcuni numeri che aiutano a capire la scala del fenomeno:

- **Oltre 1 miliardo di persone nel mondo** vive con qualche forma di disabilità (~15% della popolazione mondiale). Se includiamo i familiari direttamente coinvolti, siamo a oltre **un terzo dell'umanità**.
- Gardou (2016) chiama questo fenomeno la "**Terza nazione del mondo**": tutte le persone con disabilità messe insieme formerebbero la terza nazione per popolazione, dopo Cina e India.
- Nei paesi con alta speranza di vita, ogni persona trascorre in media **8 anni della propria vita** in condizione di disabilità.

- In Svizzera: circa **1,8 milioni di persone con disabilità**, di cui **70.000 in Ticino** (Risoluzione della sessione cantonale delle persone con disabilità, 2024).

Il numero non cala — cresce. Perché? Invecchiamento della popolazione, miglioramento delle cure neonatali (più persone sopravvivono con situazioni complesse), conflitti armati, malattie croniche.

Pensaci così: la disabilità non è qualcosa che "appartiene" a una categoria separata di persone. È parte dell'esperienza umana. Prima o poi, tutti ci entreranno in contatto — come persone, familiari, operatori sociali, o nella propria vita personale.

L'evoluzione del termine "disabilità"

Il termine ombrello ha cambiato forma nel tempo, e ogni cambio riflette un cambiamento di mentalità:

Periodo	Termine usato	Concetto sottostante
Fine anni '70	Invalido	Riabilitazione, reinserimento lavorativo
Fine anni '80	Handicappato	Integrazione
Fine anni '90	Persona disabile	Partecipazione
Dal 2000	Persona con disabilità / Persona in situazione di handicap	Inclusione come diritto

Ogni termine non è solo una parola: è un modo di vedere la persona e il suo rapporto con la società.

I modelli interpretativi della disabilità

La lezione usa un esercizio pratico per illustrare i diversi modi di leggere la stessa situazione:

Caso: Una persona su sedia a rotelle si trova ai piedi di una scala e non può accedere al seggio elettorale. Perché?

Le risposte possibili rivelano il modello mentale di chi risponde:

Modello individuale (centrato sulla persona)

- **Modello biomedico:** perché ha un danno alla spina dorsale
- **Modello funzionale/riabilitativo:** perché non può camminare

In entrambi i casi, il *problema* è nella persona. La soluzione? "Riparare" o compensare la persona.

Modello sociale (centrato sul contesto)

- **Modello ambientale:** a causa della scala, una barriera architettonica
- **Modello civico dei diritti umani:** per un'esclusione sociale, una situazione di discriminazione

Qui il *problema* è nell'ambiente e nella società. La soluzione? Cambiare l'ambiente, garantire i diritti.

Questa distinzione è fondamentale. La **Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità (CDPD)** riprende esplicitamente la visione sociale:

"La disabilità è il risultato dell'interazione tra persone con menomazioni e barriere comportamentali e ambientali, che impediscono la loro piena ed effettiva partecipazione alla società su base di uguaglianza con gli altri."

Pensa all'albero: la menomazione è un ramo storto, ma è l'ambiente (il vento, il muro, gli altri rami) a determinare se quel ramo diventa un ostacolo o no. La pianta non è "difettosa" — è l'ecosistema attorno che crea o rimuove il problema.

Le classificazioni OMS: il percorso da ICD a ICF

L'OMS ha prodotto nel tempo diversi strumenti di classificazione. [Seguire questa evoluzione è come leggere la storia del cambiamento concettuale sulla disabilità.](#)

ICD — International Classification of Diseases (versione attuale: ICD-11)

La logica è lineare e medica:

EZIOLOGIA → PATOLOGIA → MANIFESTAZIONE CLINICA

Si guarda alla *causa* della malattia. Non considera le conseguenze nella vita della persona. Utile per diagnosi clinica, limitato per capire l'impatto sociale.

Questo strumento nasce in un'epoca — dopo la Seconda Guerra Mondiale, fino agli anni '70 — dove il modello dominante era quello della **riabilitazione**: la persona con disabilità è qualcuno da "recuperare" e reintegrare nel lavoro tramite protesi che colmino una mancanza. C'è una *norma* da riacquistare.

Dagli anni '70 questo modello inizia a scricchiolare: il progresso medico porta malattie croniche che non permettono pieno recupero, e l'invecchiamento della popolazione aumenta la fragilità diffusa.

ICIDH — Classificazione Internazionale delle Menomazioni, Disabilità e Handicap (1980)

Un passo avanti importante. L'ICIDH non si ferma alla causa della malattia, ma guarda alle sue *conseguenze*. Introduce tre concetti chiave:

MALATTIA → MENOMAZIONE → DISABILITÀ → HANDICAP

- **Menomazione (impairment)**: anomalie, difetti o perdite di organi, arti, strutture o funzioni mentali. È l'esteriorizzazione di uno stato patologico.

- **Disabilità (disability):** qualsiasi restrizione o carenza (conseguente a una menomazione) della capacità di svolgere un'attività nel modo o nei limiti ritenuti normali per un essere umano.
- **Handicap:** la difficoltà che la persona incontra *nell'ambiente circostante* a causa della menomazione. È uno svantaggio *vissuto*, un problema sociale, non solo individuale.

L'ICIDH è importante perché inizia a introdurre il *contesto* nella lettura della disabilità.

Le critiche all'ICIDH (che porteranno alla sua revisione):

1. La sequenza lineare non è sempre vera: una persona può essere menomata senza essere disabile (es. una persona sorda non è "disabile" in ogni contesto — mentre ascolta musica, non c'è disabilità che emerge)
2. I concetti sono **negativi** — descrivono la persona per ciò che *non sa fare*, creando ulteriori ostacoli all'integrazione
3. Le categorie non descrivono bene anziani, bambini, persone con disturbi psichiatrici
4. Non considera adeguatamente i **fattori ambientali**, che invece hanno un ruolo determinante
5. L'handicap non è visto come concetto dinamico — può essere anche solo temporaneo

Soresi (2016) sottolinea un punto provocatorio: una persona non può essere "globalmente disabile", perché la disabilità emerge solo in certi contesti, quando si pretendono certi livelli di prestazione. Una menomazione agli arti inferiori non è disabilitante durante una partita di scacchi seduti. Una disabilità visiva non si manifesta mentre si ascolta Mozart. *Al variare del dove, del quando e del con chi*, variano le condizioni sperimentate dalla persona.

Dal PPH all'ICF: verso il modello biopsicosociale

Le critiche all'ICIDH spingono l'OMS a una revisione lunga e articolata. Nel percorso emerge il **Processo di Produzione dell'Handicap (PPH)**, che introduce una visione sistemica:

L'handicap non è una caratteristica della persona — è il risultato dell'*interazione* tra: - **Fattori personali** (sistemi organici, attitudini, capacità) - **Fattori ambientali** (facilitatori o ostacoli) - Le **abitudini di vita** della persona

Se l'ambiente è favorevole, la stessa menomazione produce meno handicap. Se l'ambiente è ostile, anche menomazioni minori diventano fortemente limitanti.

Tappe della revisione:

Anno	Documento	Novità
1980	ICIDH	Menomazione, Disabilità, Handicap
1997	ICIDH-2 bozza beta 1	Spariscono "disabilità" e "handicap" → arrivano "attività" e "partecipazione"
1999	ICIDH-2 bozza beta 2	Classificazione del funzionamento e delle disabilità
2001	ICF	Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute
2004	ICF-CY	Versione per bambini e adolescenti

L'**ICF** (2001) è la classificazione attuale. Non classifica più le malattie, ma il **funzionamento** della persona nel suo contesto. Si guarda a cosa la persona *può fare*, non solo a cosa non riesce a fare. I disturbi mentali e cognitivi vengono finalmente posti sullo stesso piano delle disabilità fisiche.

Esclusione, Segregazione, Integrazione, Inclusione

Il cuore pratico della lezione: come le istituzioni hanno storicamente considerato le persone con disabilità. Il modello di **Mainardi (2010)** distingue quattro forme, leggibili su due assi:

- **Asse X (orizzontale):** luoghi — da *speciali/separati* a *ordinari*
- **Asse Y (verticale):** tipo di attenzione — da *nessuna attenzione* ad *attenzioni speciali*

Esclusione / Ghettizzazione

- Luoghi speciali/separati + **nessuna attenzione** educativa
- L'educazione è un privilegio, non un diritto. Un muro separa chi può beneficiarne e chi no.
- Esempi storici: manicomi, internamenti senza finalità educativa, esclusione dalla società.

Segregazione

- Luoghi speciali/separati + **attenzioni speciali**
- Si creano gruppi omogenei per caratteristiche simili, con l'obiettivo di una prestazione più specialistica.
- **Non è automaticamente "male":** certi centri specializzati offrono qualità di vita molto alta per persone con necessità elevate (piscine, terapie, accessibilità totale). Per queste persone, la separazione non è esclusione — è risposta adeguata a bisogni specifici.
- Anche la scuola ordinaria funziona in parte in logica segregativa: gruppi per età, per competenze, per territorio.

Integrazione

- Luoghi **ordinari** + **attenzioni speciali**
- La persona con disabilità entra nei contesti comuni, ma con misure speciali e negoziate.
- **L'integrazione è nell'ordine delle possibilità:** richiede battaglie individuali, dipende dalla disponibilità di chi gestisce il contesto.
- **Esempio concreto:** i genitori di un bambino su sedia a rotelle negoziano con la direzione scolastica la costruzione di una rampa *per quel bambino*. Misura speciale, eccezionale, ma possibile.
- Gardou (2016): nell'integrazione è la *persona* che deve adattarsi al sistema preesistente — "un elemento esterno inserito dentro che deve normalizzarsi".

Inclusione

- Luoghi **ordinari** + **attenzioni normalmente speciali**

- Le attenzioni speciali diventano la norma per tutti, a priori.
- L'educazione è rivolta a tutti senza eccezioni, senza costituire gruppi su nessun criterio.
- **Esempio concreto:** tutti gli edifici pubblici hanno rampe *a priori*, indipendentemente dalla presenza di persone su sedia a rotelle. La misura è pensata per tutta la popolazione — utile anche a mamme con passeggino, ciclisti in stazione, anziani con bagagli.
- Gardou (2016): una società inclusiva "sa modulare il proprio funzionamento, diventa flessibile per offrire a tutti un luogo in cui sentirsi a casa."

Attenzione importante: **questo schema non è una scala del bene e del male**. La prof. sottolinea con forza che non c'è un giudizio di valore automatico. In certi momenti, per certe persone, la soluzione migliore per la qualità di vita è separativa. La stessa struttura, la stessa persona, possono spostarsi su questo schema a seconda del momento e del bisogno.

L'inclusione: ideale, utopia e i suoi rischi

L'inclusione è oggi la parola di moda — e questo crea problemi.

Il problema della banalizzazione

La prof. porta l'esempio di Sanremo: un coro di persone con disabilità cognitive, vestite con magliette rosse con scritto "solo come te", presentato come "momento inclusivo". Per la prof. era il contrario: persone segregate su un palco, trattate in modo paternalistico, non valorizzate individualmente. Le associazioni per i diritti delle persone con disabilità avevano già scritto a Sanremo chiedendo di non parlare di disabilità in quel modo.

L'inclusione è diventata un'etichetta da applicare a qualsiasi cosa, anche a pratiche che non hanno niente di inclusivo.

L'inclusione come direzione, non come stato raggiunto

La risposta della prof. alla domanda "L'inclusione è un'utopia?": sì, è un'utopia — ma è la direzione. Per alcune categorie si è già progredito molto: gli immigrati italiani negli anni '60-'70 in Svizzera erano esclusi, oggi quel livello di esclusione non esiste più. Con le disabilità fisiche, grazie a tecnologia e norme di accessibilità, molte persone sono molto più incluse di 30 anni fa.

Il rischio del "mettere dentro senza garantire"

Se creo contesti inclusivi ma poi taglio le risorse per i sostegni, piano piano le persone vengono dimenticate e ri-escluse. Non basta "mettere dentro" — bisogna continuare a garantire le attenzioni speciali nel tempo. Il rischio dell'inclusione senza risorse è tornare all'esclusione di partenza.

Oltre l'inclusione?

Una sociolinguista citata a lezione fa notare che la stessa parola "inclusione" porta un problema: implica che qualcuno *include* qualcun altro. C'è ancora una relazione asimmetrica. L'ideale successivo sarebbe la **vera convivenza nella differenza** — ma le parole per descriverla ancora non abbiamo.

Gardou propone di usare soprattutto l'**aggettivo inclusivo** (scuola inclusiva, educazione inclusiva) perché porta il valore dell'inclusione sul piano delle pratiche concrete — qualcosa su cui possiamo agire ogni giorno.

La lingua facile: integrativa o inclusiva?

La **lingua facile** è una modalità di scrittura semplificata (parole comuni, frasi brevi, layout chiaro) per rendere i testi accessibili a persone con difficoltà cognitive o di lettura.

La domanda posta a lezione: è uno strumento integrativo o inclusivo?

- Se disponibile *solo per chi la richiede* (es. un telegiornale speciale in certi orari) → **integrativa**: misura speciale eccezionale per persone specifiche

- Se *tutti i testi* (circolari scolastiche, documenti medici, comunicazioni dei comuni) fossero in lingua facile *a priori* → **inclusiva**: misura normale per tutta la popolazione

Lo **strumento in sé** è inclusivo: rendere la comunicazione più chiara beneficia chiunque. Il suo *utilizzo* contestuale può essere integrativo, inclusivo, o addirittura segregativo a seconda di come viene applicato.

Domande di orientamento allo studio

Qual è la differenza tra ICD, ICIDH e ICF? Cosa rappresenta questa evoluzione? L'ICD classifica le malattie per cause (eziologia → patologia → manifestazione clinica) — è un modello medico-riabilitativo che non considera le conseguenze nella vita della persona. L'ICIDH (1980) fa un passo avanti: guarda alle conseguenze delle malattie, introducendo i concetti di menomazione, disabilità e handicap in sequenza lineare. L'ICF (2001) abbandona la logica delle conseguenze per classificare il funzionamento della persona nel suo contesto — si chiede cosa la persona può fare, non solo cosa non riesce a fare. Questa evoluzione riflette il passaggio dal modello medico al modello biopsicosociale: l'attenzione si sposta dalla "persona da riparare" al "sistema da adattare".

Cosa si intende per menomazione, disabilità e handicap nell'ICIDH?

Perché è stato criticato questo strumento? Nell'ICIDH: la menomazione è il danno organico o funzionale (anomalia di organi, strutture o funzioni mentali); la disabilità è la restrizione o carenza di capacità che ne consegue; l'handicap è lo svantaggio vissuto dalla persona nell'interazione con l'ambiente. Le critiche principali: la sequenza lineare menomazione→disabilità→handicap non è sempre vera (una persona sorda non è "disabile" mentre ascolta musica); il linguaggio è negativo perché descrive la persona solo per ciò che non sa fare; i fattori ambientali — che hanno un ruolo determinante — sono sottovalutati; l'handicap non è concepito come fenomeno dinamico, sebbene possa essere temporaneo.

Qual è la differenza pratica tra integrazione e inclusione? Perché questa distinzione è fondamentale per il lavoro sociale? Nell'integrazione, la persona con disabilità entra in contesti ordinari, ma con misure speciali ed

eccezionali, negoziate caso per caso: è la persona che si adatta al sistema. È "nell'ordine delle possibilità" — richiede una battaglia individuale. Esempio: una rampa costruita per un bambino specifico. Nell'inclusione, invece, le misure speciali diventano la norma per tutta la popolazione, a priori: è il sistema che si adatta a tutti. Esempio: rampe in tutti gli edifici pubblici indipendentemente da chi li usa. Per il lavoro sociale, capire questa distinzione è fondamentale: agire in ottica inclusiva significa progettare il contesto pensando a tutti, non solo rispondere a emergenze individuali. Attenzione: non si tratta di una scala del bene e del male — in certi momenti, per certe persone, la soluzione più adeguata è separativa.

Perché il linguaggio che usiamo per descrivere la disabilità è importante? Quali termini sono da evitare e perché? Il linguaggio non è neutro: riflette e rinforza il modello interpretativo che abbiamo della persona. L'evoluzione terminologica (invalido → handicappato → persona disabile → persona con disabilità) segue l'evoluzione dei modelli interpretativi. La regola fondamentale è "la persona prima del deficit": si dice "persona con disabilità", non "il disabile" o "il disabili". Da evitare: invalido (retaggio assicurativo), diversamente abile (presuppone sempre capacità alternative — non necessariamente vero), portatore di handicap (la persona vive situazioni di handicap, non le porta), "il cieco" o "il sordo" (riduce la persona a un tratto). Da usare: persona con disabilità, persona in situazione di handicap, persona con disabilità visiva/uditiva/motoria.

Cos'è il Processo di Produzione dell'Handicap (PPH) e come si differenzia dall'ICIDH? Il PPH è un modello sistemico che introduce una visione dell'handicap come risultato dell'interazione tra fattori personali (sistemi organici, attitudini, capacità) e fattori ambientali (che possono essere facilitatori o ostacoli), in relazione alle abitudini di vita della persona. A differenza dell'ICIDH — che presenta una sequenza lineare e colpevolizza la persona per le sue limitazioni — il PPH mostra che lo stesso deficit produce handicap diversi a seconda dell'ambiente: un ambiente favorevole riduce l'handicap, uno ostile lo amplifica. Il PPH ha anticipato concettualmente l'ICF, portando la logica dell'interazione persona-ambiente al centro della classificazione.

Qual è il rischio principale dell'inclusione mal applicata? Cosa significa che l'inclusione è una "direzione" e non uno "stato raggiunto"? Il rischio principale è creare contesti formalmente inclusivi (aprire le porte) senza garantire i

sostegni necessari nel tempo. Se le risorse vengono tagliate dopo l'inserimento, le persone vengono gradualmente dimenticate e ri-escluse — si torna all'esclusione di partenza, ma mascherata da inclusione. L'inclusione non è un traguardo raggiunto una volta per sempre: è una direzione verso cui tendere continuamente. Per alcune categorie (es. accessibilità fisica) si è già avanzato molto; per altre (inserimento lavorativo, scelta della residenza) c'è ancora molto lavoro. Questo richiede continuità di risorse, attenzione e impegno politico nel tempo.

Concetti chiave

Termine	Significato
Menomazione (impairment)	Danno organico o funzionale (organi, strutture, funzioni mentali)
Disabilità (disability)	Perdita di capacità operative conseguente alla menomazione
Handicap	Svantaggio vissuto dalla persona nell'interazione con l'ambiente
ICD	Classifica le malattie per cause — modello medico/riabilitativo
ICIDH	Classifica le conseguenze delle malattie — introduce menomazione, disabilità, handicap (1980)
ICF	Classifica il funzionamento della persona nel contesto — modello biopsicosociale (2001)
PPH	Processo di Produzione dell'Handicap — modello sistemico persona-ambiente
Esclusione	Luoghi speciali + nessuna attenzione educativa
Segregazione	Luoghi speciali + attenzioni speciali
Integrazione	Luoghi ordinari + attenzioni speciali (misure eccezionali, negoziate)

Termine	Significato
Inclusione	Luoghi ordinari + attenzioni normalmente speciali (per tutti, a priori)
Lingua facile	Scrittura semplificata per rendere i testi accessibili a tutti
Persona con disabilità	Terminologia corretta: la persona viene prima della disabilità

Collegamenti

- **Lezioni 01-04:** movimenti associativi e Convenzione ONU (CDPD, 2006) — base valoriale da cui derivano i cambiamenti concettuali discussi qui
- **Libro di Gardou** (*Nessuna vita è minuscola*, 2016): approfondisce inclusione, diritti e visione di una società senza esclusi
- **Mainardi (2010):** schema dei quattro modelli istituzionali (esclusione, segregazione, integrazione, inclusione)
- **Soresi (2016):** analisi critica delle classificazioni OMS e della loro evoluzione
- **Da approfondire:** Universal Design for Learning (UDL) — progettare ambienti di apprendimento accessibili a tutti fin dall'inizio